

Chuyển lưu nước tiểu ra da có kiểm soát (Túi Indiana)

Thông tin cho bệnh nhân · Túi chứa bên trong được làm trống bằng ống thông — không cần túi ngoài

WARWIKI

Chuyển lưu nước tiểu ra da có kiểm soát là một túi chứa bên trong được tạo từ ruột của chính bạn, giữ nước tiểu trong cơ thể qua một lỗ mở (stoma) nhỏ, không rỉ nước — thường nằm ở rốn. Thay vì đeo túi ngoài, bạn làm trống túi bằng cách đưa ống thông qua lỗ mở vài lần mỗi ngày. Túi Indiana là loại phổ biến nhất.

Về ca phẫu thuật này

Một đoạn **ruột già và ruột non** được tạo hình thành một **túi chứa** áp lực thấp trong bụng; niệu quản (ống dẫn từ thận) dẫn nước tiểu vào đó. Một kênh ngắn có **van một chiều** được đưa ra da — thường là **rốn** — tạo thành một lỗ mở (stoma) nhỏ, phẳng, giữ khô giữa các lần thông tiểu.

- Bạn đưa ống thông để làm trống túi khoảng **mỗi 4–6 giờ**.
- Bạn **súc rửa (tưới)** túi để làm sạch chất nhầy.
- **Không cần túi ngoài** — chỉ cần một miếng đệm nhỏ hoặc băng che lỗ mở.

Đây là lựa chọn tốt cho người muốn không đeo túi ngoài, không phù hợp với bàng quang nhân tạo (hoặc không muốn), và có thể **tự thông tiểu đều đặn** — cần bàn tay và thị lực ổn định, hoặc có người chăm sóc hỗ trợ.

Có an toàn không?

Đây là phương pháp kiểm soát nước tiểu đã được áp dụng rộng rãi. Phẫu thuật lớn hơn và dài hơn so với dẫn lưu bằng ống hồi tràng, và cần tự thông tiểu suốt đời. Rủi ro gồm: chảy máu, nhiễm trùng, rò rỉ, khó đưa ống thông hoặc lỗ mở bị hẹp hay rỉ (đôi khi cần phẫu thuật điều chỉnh), sỏi trong túi, chất nhầy, nhiễm trùng đường tiết niệu, và thay đổi muối/vitamin/thận cần theo dõi lâu dài.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Chuyển lưu có kiểm soát

Hệ thống nước tiểu không rỉ — bạn kiểm soát khi nào làm trống.

Túi Indiana

Túi chứa kiểm soát phổ biến nhất, được tạo từ ruột già phải và ruột non.

Túi chứa (reservoir)

Túi bên trong làm từ ruột, giữ nước tiểu.

Lỗ mở (stoma)

Lỗ nhỏ trên da (thường là rốn) để đưa ống thông vào.

Tự thông tiểu

Đưa ống mỏng qua lỗ mở để làm trống túi chứa.

Súc rửa (irrigate)

Bơm nước vào túi để làm sạch chất nhầy.

Niệu quản

Ống dẫn nước tiểu từ thận; dẫn vào túi chứa.

Chất nhầy

Dịch nhờn do ruột tiết ra; làm sạch định kỳ là một phần chăm sóc thường ngày.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân, bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, bạn sẽ đau nhức vùng bụng và ruột cần vài ngày để “thức dậy.” Bạn sẽ ra viện với một ống thông trong túi (kèm stent mềm) trong khoảng 3–4 tuần khi lành — cần súc rửa đều để làm sạch chất nhầy. Hầu hết bệnh nhân nằm viện khoảng 5–8 ngày.

Cách chuẩn bị (Trước phẫu thuật)

- Thực hiện dưới **gây mê toàn thân** — tuân thủ mọi hướng dẫn (nhịn ăn, tạm ngừng thuốc làm loãng máu theo chỉ dẫn). Bạn có thể cần **chuẩn bị ruột**.
- Nhóm chăm sóc lên kế hoạch **vị trí lỗ mổ** (thường là rốn) và xác nhận bạn — hoặc người chăm sóc — có thể **tự thông tiểu suốt đời**.
- Không hút thuốc** và sắp xếp người hỗ trợ tại nhà sau phẫu thuật.

Thông báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc làm loãng máu**, hoặc đang bị nhiễm trùng
- Có **bệnh ruột**, vấn đề thận, hoặc khó khăn về **tay hoặc thị lực** ảnh hưởng đến việc thông tiểu

Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được gây mê và dùng kháng sinh.
- 2 Một đoạn ruột được tách ra và phần còn lại được nối lại.
- 3 Đoạn ruột được tạo hình thành túi chứa; một kênh có van một chiều được đưa ra da thành lỗ mổ.
- 4 Niệu quản được nối vào; đặt ống thông túi và stent mềm trong thời gian lành thương.

Sau phẫu thuật

- Bạn về nhà sau khoảng **5–8 ngày** với **ống thông túi trong ~3–4 tuần**; súc rửa đều để làm sạch chất nhầy.
- Sau khi ống được rút và túi lành, bạn **tự thông tiểu qua lỗ mổ mỗi 4–6 giờ** và súc rửa để làm sạch chất nhầy.
- Lỗ mổ luôn **khô** — chỉ cần miếng đệm nhỏ hoặc băng che (không cần túi ngoài).
- Chất nhầy là bình thường; uống nhiều nước; theo dõi lâu dài (vitamin B12, kiểm tra túi). **Tránh nâng vật nặng ~6 tuần**.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cấp cứu ngay nếu bạn:

- Không thể đưa ống thông qua hoặc không có nước tiểu ra** — túi có thể quá đầy, cần dẫn lưu khẩn cấp
- Có sốt hoặc ớn lạnh
- Đau bụng dữ dội, nôn, hoặc **không có hơi hay phân**
- Chảy máu nhiều hoặc cục máu đông làm tắc ống thông, hoặc vết thương đỏ hoặc có dịch tiết

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Túi Indiana giữ nước tiểu bên trong cơ thể qua một lỗ mổ nhỏ không rỉ, làm trống bằng ống thông — không cần túi ngoài.
2. Bạn sẽ tự thông tiểu qua lỗ mổ mỗi 4–6 giờ và súc rửa để làm sạch chất nhầy, suốt đời — cần bàn tay và thị lực ổn định (hoặc có người hỗ trợ).
3. Chuẩn bị bằng nhịn ăn và chuẩn bị ruột, không hút thuốc, và sắp xếp người hỗ trợ. Đến cấp cứu ngay nếu không thể đưa ống thông qua hoặc không có nước tiểu ra.